Expertenblatt A · Hypovolämischer Schock

Papierfassung (freiwillig): Die Aufträge, den Fall zum Markieren und den Experten-Check finden Sie in der Stunden-App auf Ihrem Handy. Hier können Sie Fall und Infotext zusätzlich auf Papier lesen und markieren.

Fallsituation

Herr Gerhard Albrecht (81) lebt seit vier Jahren im Pflegeheim „Am Kocherufer“. Wegen eines Vorhofflimmerns nimmt er einen Gerinnungshemmer. Er hört schlecht und trägt deshalb zwei Hörgeräte. Am Vormittag hatte er schwarzen, klebrigen Stuhlgang. Danach hat er mit seinem Zimmernachbarn Karten gespielt.

Als Sie ihn um 11:30 Uhr zum Mittagessen an die Bettkante setzen wollen, sagt er: „Mir wird ganz schwarz vor Augen.“ Er ist blass, seine Stirn ist kalt und feucht. Auf seinem Nachttisch steht ein Foto seiner Enkelin. Mehrmals bittet er um etwas zu trinken. Er wirkt unruhig und fragt, wo seine Frau sei, obwohl er sonst gut orientiert ist. Sie messen: Puls 116/min, Blutdruck 98/72 mmHg, Atemfrequenz 24/min. Bei der Morgenrunde lagen die Werte bei Puls 78/min und Blutdruck 145/85 mmHg. Seine Tochter hat sich für den Nachmittag zum Besuch angemeldet.

Informationstext A: Hypovolämischer Schock

Bei einem hypovolämischen Schock hat die Person meist einen schnellen, schwachen Puls und eine blasse, kalte, schweißige Haut. Viele haben großen Durst, sind unruhig, ängstlich oder plötzlich verwirrt, atmen schnell und scheiden wenig Urin aus. Der Blutdruck fällt oft erst spät – aussagekräftig ist der Vergleich mit dem Vorwert (Schockindex).

Pflegefachpersonen behalten vor allem im Blick, wo Blut verloren gehen könnte (Stuhl, Erbrochenes, Verband, Drainage). Sie kontrollieren Puls und Blutdruck im Verlauf, das Bewusstsein und die Urinausscheidung.

Ausgelöst wird der hypovolämische Schock durch einen Verlust von Blut oder Flüssigkeit: durch eine Blutung – sichtbar nach außen oder verborgen im Körper wie bei einer Magen-Darm-Blutung –, durch Verbrennungen oder durch starken Durchfall und Erbrechen. Gerinnungshemmer erhöhen das Blutungsrisiko. Schwarzer, klebriger Stuhl (Teerstuhl) weist auf eine Blutung im Magen oder Zwölffingerdarm hin.

Im Notfall: Hilfe holen, Ärztin oder Arzt informieren; die Person nicht aufsetzen oder aufstehen lassen; flach lagern, Beine hoch (wenn keine Atemnot); Wärme erhalten; nichts essen oder trinken lassen (mögliche Untersuchung oder Operation); engmaschig überwachen. Volumen gibt es nur nach ärztlicher Anordnung.

Im Körper läuft dabei eine Kette ab: Weniger Volumen → weniger Blut fließt zum Herzen zurück → das Herz kann weniger auswerfen (das Schlagvolumen sinkt) → der Blutdruck droht zu fallen. Der Sympathikus gleicht aus: Der Puls steigt, die Gefäße in Haut, Muskeln, Niere und Darm verengen sich (Zentralisation, siehe Woche 1). Hält der Verlust an, gerät der Körper in die Schockspirale.

Quelle: nach MSD Manual Profi-Ausgabe: Schock; S2k-Leitlinie Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); sprachlich vereinfacht.

Wörterhilfe: hypovolämisch = mit zu wenig Volumen | Teerstuhl = schwarzer Stuhl durch verdautes Blut | Zentralisation = Umverteilung des Blutes zu Gehirn und Herz

Expertenblatt B · Anaphylaktischer Schock

Papierfassung (freiwillig): Die Aufträge, den Fall zum Markieren und den Experten-Check finden Sie in der Stunden-App auf Ihrem Handy. Hier können Sie Fall und Infotext zusätzlich auf Papier lesen und markieren.

Fallsituation

Mia (19) ist Auszubildende im ersten Ausbildungsdrittel und mit Ihnen auf einer internistischen Station eingesetzt. Es ist ihr dritter Tag auf der Station. In der Pause isst sie ein Stück Geburtstagskuchen, das Haselnüsse enthält. Dabei erzählt sie von ihrem Wochenende im Kletterpark. Mia erwähnt, dass es bei Nüssen „schon mal im Mund gekribbelt“ habe.

Zehn Minuten später kratzt sie sich an Hals und Händen, auf Hals und Brust bilden sich Quaddeln. Ihre Lippen und Augenlider schwellen an. Auf dem Stationsflur ist es gerade ruhig. Mit heiserer Stimme sagt sie: „Mir ist schlecht, und mir ist so schwindelig.“ Sie hat Bauchkrämpfe. Ihre Kollegin misst: Puls 128/min, Blutdruck 88/50 mmHg, Atemfrequenz 26/min, Sauerstoffsättigung 93 %. Sie notiert die Werte auf einem Zettel. Mia sagt, ihr Blutdruck sei sonst „immer so 120 zu 70“.

Informationstext B: Anaphylaktischer Schock

Kommt der Körper mit dem Allergen in Kontakt, setzen Mastzellen schlagartig Histamin und weitere Botenstoffe frei. Die Gefäße werden weit und durchlässig: Flüssigkeit tritt ins Gewebe aus (Quaddeln, Schwellungen), im Gefäßsystem fehlt Volumen (relativer Volumenmangel) → der Blutdruck fällt. Gleichzeitig schwellen die Schleimhäute an (z. B. im Kehlkopf) und die Bronchien verengen sich → Atemnot und Sauerstoffmangel. Das Herz versucht, mit einem schnellen Puls auszugleichen.

Im Notfall: Allergen stoppen, Hilfe holen, nach Leitsymptom lagern, Adrenalin i. m. nach Anordnung oder SOP geben (Mittel der ersten Wahl), überwachen, dokumentieren – mehr dazu in AA3 bis AA5.

Die Beschwerden betreffen oft mehrere Organe gleichzeitig: Juckreiz, Rötung, Quaddeln und Schwellungen der Haut; Heiserkeit, Kloßgefühl, pfeifende Atmung, Atemnot und sinkende Sauerstoffsättigung; ein schneller Puls, Blutdruckabfall, Schwindel und Bewusstseinsstörungen; Übelkeit, Erbrechen und Bauchkrämpfe. Achtung: Die Haut kann auch blass sein – die Veränderungen an der Haut sind nicht immer deutlich.

Der anaphylaktische Schock ist eine allergische Sofortreaktion des Immunsystems auf einen eigentlich harmlosen Stoff (Allergen), z. B. Medikamente, Insektengift (Wespe, Biene) oder Nahrungsmittel (Nüsse, Erdnüsse, Sellerie, Fisch). Die Reaktion beginnt Sekunden bis Minuten nach dem Kontakt.

Pflegefachpersonen beobachten vor allem die Atemwege und die Atmung (Heiserkeit, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung) sowie den Kreislauf. Nach Stunden kann eine zweite Reaktion folgen (zweigipfliger Verlauf) – deshalb ist eine Nachbeobachtung nötig.

Quelle: nach MSD Manual Profi-Ausgabe: Schock; S2k-Leitlinie Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); sprachlich vereinfacht.

Wörterhilfe: Allergen = Auslöser einer Allergie | Mastzellen = Abwehrzellen im Gewebe, die Histamin speichern | Quaddeln = juckende, erhabene Hautschwellungen | anaphylaktisch = durch eine schwere allergische Reaktion

Expertenblatt C · Neurogener Schock

Papierfassung (freiwillig): Die Aufträge, den Fall zum Markieren und den Experten-Check finden Sie in der Stunden-App auf Ihrem Handy. Hier können Sie Fall und Infotext zusätzlich auf Papier lesen und markieren.

Fallsituation

An einem Sonntagnachmittag sind Sie privat mit Freunden am Baggersee. Tobias Weber (24) springt kopfüber vom Steg ins Wasser – an einer Stelle, an der das Wasser nur hüfttief ist. Seine Freunde ziehen ihn sofort ans Ufer. Kurz vorher hatte er sich noch mit Sonnencreme eingecremt. Er studiert Sport und spielt in einem Volleyballverein.

Herr Weber ist wach und sagt: „Ich spür meine Beine nicht. Und meine Hände kribbeln." Er klagt über starke Nackenschmerzen. Am Steg läuft laute Musik. Arme und Beine kann er kaum bewegen. Seine Atmung ist flach. Sie tasten einen langsamen Puls von 52/min. Die Haut an seinen Beinen ist warm, trocken und rosig. Er fragt, ob jemand sein Handy gesehen hat. Der Rettungsdienst misst später einen Blutdruck von 82/45 mmHg.

Informationstext C: Neurogener Schock

Den neurogenen Schock erkennt man an einem niedrigen Blutdruck bei langsamem oder normalem Puls. Unterhalb der Verletzung ist die Haut warm, trocken und rosig; dort bestehen Lähmungen und Gefühlsstörungen (Kribbeln, Taubheit). Oft klagt die Person über Nacken- oder Rückenschmerzen, der Körper kühlt leicht aus, und bei sehr hoher Verletzung ist auch die Atmung gestört. Achtung: Die Person wirkt „stabil" – ruhiger Puls, rosige Haut –, ist aber im Schock.

Pflegefachpersonen kontrollieren vor allem die Atmung, Blutdruck und Puls im Verlauf, die Körpertemperatur sowie Lähmungen und Gefühl im Verlauf. Nach einem Unfall kann zusätzlich eine Blutung vorliegen.

Im Rückenmark verlaufen auch die Nervenbahnen des Sympathikus. Sind sie unterbrochen, fehlt den Gefäßen unterhalb der Verletzung die Spannung: Sie werden weit, das Blut „versackt", es kommt zu einem relativen Volumenmangel → der Blutdruck fällt. Weil der Sympathikus ausfällt, kann der Körper nicht gegensteuern: Der Puls steigt nicht an (oft ist er sogar langsam), und es gibt keine Zentralisation.

Im Notfall: Notruf veranlassen; den Kopf mit beiden Händen in der vorgefundenen Lage halten; nicht aufsetzen, nicht bewegen; Wärme erhalten; Atmung und Puls überwachen (mehr in Woche 4).

Der neurogene Schock folgt auf eine Verletzung des Rückenmarks, meist im Bereich der Halswirbelsäule oder der oberen Brustwirbelsäule – z. B. nach einem Kopfsprung in flaches Wasser, einem Sturz aus der Höhe oder einem Verkehrsunfall.

Quelle: nach MSD Manual Profi-Ausgabe: Schock; S2k-Leitlinie Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); sprachlich vereinfacht.

Wörterhilfe: neurogen = vom Nervensystem ausgehend | Rückenmark = Nervenstrang im Wirbelkanal | Sympathikus = Teil des Nervensystems, der Puls und Gefäßspannung steigert